PNEUMOLOGIA · AULA 6 · TABAGISMO

Tabagismo e cigarros eletrônicos

Da dependência à cessação: abordagem, tratamento e riscos dos novos produtos.

C

Dr. Cássio
Professor de Pneumologia · 28 de outubro de 2026

TRÊS NÚMEROS PARA LEVAR

3
dimensões da dependência

7–30 dias
intervalo para combinar o Dia D

5%
50 mg/mL no exemplo do rótulo

NESTA APOSTILA

00 Recados da disciplina 2
01 Por que é difícil parar? 3
02 Abordar e avaliar 4
03 Apoio comportamental e Dia D 5
04 Medicamentos: indicação e diferenças 7
05 Cessação, recaída e seguimento 10
06 Cigarros eletrônicos e a conta do rótulo 11
07 Lesão pulmonar e redução de danos 13
08 Prevenção e cuidado compartilhado 14
09 Página de véspera 15
10 Glossário, fontes e anotações 16

Entenda a dependência, organize o cuidado e revise as decisões que fazem diferença para o paciente.

COMO LER ESTA APOSTILA

- **Azul** conteúdo e raciocínio da aula
- **Vermelho** pegadinha ou alerta
- **Roxo** complemento fora da aula
- **Em palavras simples** abertura do capítulo
- **Verde** dose ou valor de referência
- **Laranja** fala do professor
- PROVA **Prova** destaque do professor
- **Você está aqui** posição na trilha

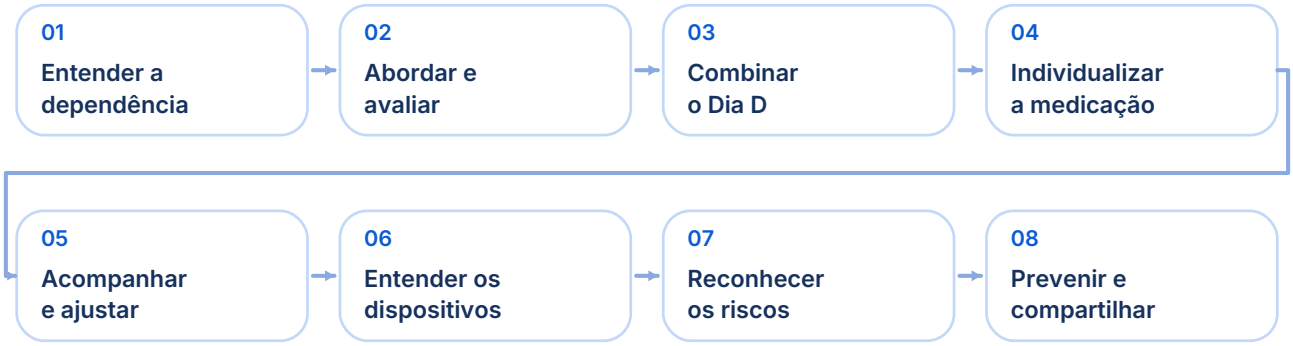
SOBRE O PROFESSOR · DR. CÁSSIO

ATUAÇÃO	Professor de Pneumologia, com experiência em grupo de tratamento do tabagismo na Unimed.

SEÇÃO 00

Recados da disciplina

AVALIAÇÃO	11 questões em formato de casos clínicos, valendo **5,0 pontos no total**.
FORMATO	Alternativas A, B, C e D, sem combinações de assertivas do tipo “I e II corretas”.
ORGANIZAÇÃO	A possibilidade de ampliação do tempo da prova depende de confirmação pela disciplina.



Siga a trilha: entender o problema, combinar o cuidado e acompanhar a mudança.

A lógica do cuidado é entender por que a pessoa fuma, construir um plano que faça sentido para ela e acompanhar o que acontece depois. O medicamento é uma parte desse processo.

> “Se você não tem tempo e paciência para escutar o tabagista, você não vai conseguir chegar a lugar nenhum.”
>
> DR. CÁSSIO

SEÇÃO 01

Por que é difícil parar?

EM PALAVRAS SIMPLES

Parar de fumar envolve o que o corpo pede, o que a pessoa sente e o que ela se acostumou a fazer. Por isso, tratar só a nicotina deixa parte do problema sem cuidado.

O tabagismo é um **transtorno crônico relacionado ao uso e à dependência de nicotina**, associado à exposição a produtos inalados e a danos agudos e crônicos. A nicotina permanece no centro do problema, mesmo com a diversidade de produtos: cigarro convencional, narguilé, cigarros eletrônicos e outras formas de tabaco.

O dano não aparece apenas depois de muitos anos. Os cigarros eletrônicos também podem estar associados à lesão pulmonar aguda. Entre os danos de longo prazo estão câncer, infarto e doença pulmonar obstrutiva crônica.

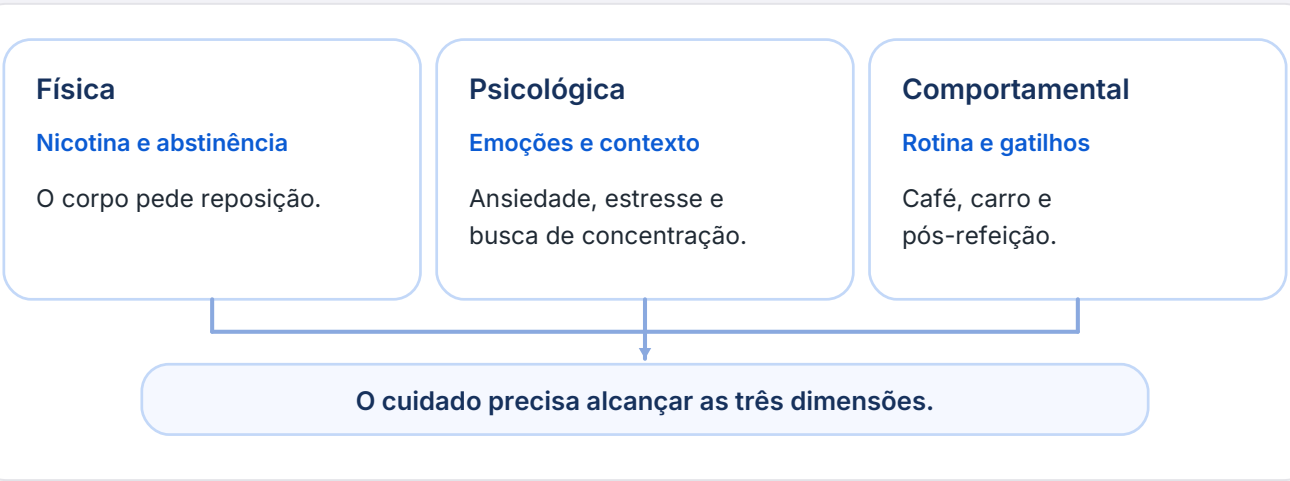
Uma distinção importante. A dependência é crônica; os danos à saúde podem ser agudos ou crônicos. Uma exposição recente não garante ausência de risco.

Uma doença evitável que continua relevante

Como dimensão do problema, o Dr. Cássio apresenta estimativas de 1,2 bilhão de pessoas que fumam, mais de 7 milhões de mortes relacionadas ao tabagismo e 1,5 milhão relacionadas à exposição passiva. A carga de doença vai além do pulmão e inclui alterações cardíacas e vasculares.

Panorama epidemiológico. São estimativas de ordem de grandeza. A redução do consumo de cigarros convencionais convive com o crescimento dos cigarros eletrônicos, o que exige atenção à mudança dos produtos e dos padrões de uso.

As três dimensões da dependência



Na dimensão física, a nicotina chega rapidamente ao cérebro — cerca de **4 segundos**, na explicação do Dr. Cássio — e ativa receptores ligados à sensação de recompensa. Quando o efeito passa, surge a busca por nova exposição.

A dimensão psicológica aparece na relação do cigarro com ansiedade, estresse, concentração e emoções. A pessoa pode associá-lo tanto a um momento difícil quanto a uma comemoração.

A dimensão comportamental é sustentada pela repetição: entrar no carro, terminar o almoço, tomar café ou ir à padaria passam a lembrar o cigarro. Essa parte pode ser esquecida tanto pelo paciente quanto pelo médico, embora seja decisiva para romper a associação com a rotina.

> “Como é que eu vou tirar o meu cigarro do meu dia a dia se eu fizer as mesmas coisas na minha rotina de sempre?”
>
> DR. CÁSSIO

PEGADINHA DO PROFESSOR

Achar que tratar a nicotina resolve tudo. A rotina e a relação emocional com o cigarro também precisam entrar no plano.

SEÇÃO 02

Abordar e avaliar

EM PALAVRAS SIMPLES

Toda consulta pode abrir espaço para ajudar quem fuma. Antes de combinar o tratamento, é preciso entender a vontade de parar, as dificuldades e as tentativas anteriores.

Todo usuário deve ser abordado, mesmo quando ainda não está pronto para parar. O objetivo é oferecer ajuda e explicar benefícios, sem impor uma decisão nem transformar a consulta em repreensão. Uma consulta por tosse ou por outro motivo também pode abrir essa conversa.

> “Eu posso te ajudar a parar se você quiser.”
>
> DR. CÁSSIO

Cinco passos para organizar a consulta

1. **Perguntar.** Investigar se usa tabaco ou nicotina e qual produto utiliza, incluindo vape e pod.
2. **Aconselhar.** Recomendar a cessação de forma clara e personalizada, enfatizando benefícios e oferecendo ajuda.
3. **Avaliar.** Explorar motivação, dependência, tentativas prévias, comorbidades e o momento de vida.
4. **Ajudar.** Construir com a pessoa um plano de ação para parar.
5. **Acompanhar.** Verificar dificuldades, sustentar a mudança e prevenir recaídas.

A sequência organiza o cuidado sem transformar a consulta em um roteiro rígido. Duas perguntas orientam o início: **“Você quer parar?” e “Este é um bom momento para você?”**. Um paciente motivado, mas vivendo demissões e insegurança no trabalho, pode precisar de um plano que leve esse contexto em conta.

Também é necessário diferenciar quem não consegue interromper o uso de quem para, mas volta depois. Nesse segundo cenário, o plano precisa dar atenção especial à manutenção da cessação e aos gatilhos da recaída.

PEGADINHA DO PROFESSOR

Tratar a ambivalência como falta de vontade ou de caráter. O tabagismo é uma doença, e a dependência tem componentes físicos, psicológicos e comportamentais.

Fagerström: um instrumento dentro da avaliação

O teste ajuda a avaliar a dependência de nicotina. Duas perguntas têm especial importância clínica: **quanto tempo passa até o primeiro cigarro ao acordar e quantos cigarros a pessoa fuma por dia**.

0–2 PONTOS	Dependência muito baixa.
3–4 PONTOS	Dependência baixa.
5 PONTOS	Dependência média.

Faixas iniciais da classificação: o escore é parte da avaliação, não uma decisão de tratamento isolada.

O resultado precisa ser interpretado junto do padrão atual de uso, da história de abstinência e das tentativas anteriores: o que a pessoa sentiu, por que voltou e o que atrapalhou o tratamento. O instrumento integra a avaliação do tabagismo, mas não substitui a história clínica.

> “Existe uma doença que é tabagismo e a gente precisa tratar você.”
>
> DR. CÁSSIO

SEÇÃO 03

Apoio comportamental e Dia D

Dependência | Abordagem | **Dia D** | Medicamentos | Seguimento | Dispositivos | Riscos | Prevenção

EM PALAVRAS SIMPLES

O plano precisa caber na vida da pessoa. Marcar uma data, reconhecer os gatilhos e mudar a rotina ajuda a tirar o cigarro dos momentos em que ele aparecia automaticamente.

Apoio comportamental PROVA

Os dois eixos do tratamento são o apoio comportamental e o tratamento farmacológico. Para a prova, adote a expressão **apoio comportamental**, como orientado pelo Dr. Cássio. A associação com medicação, quando indicada, é mais eficaz do que cada abordagem isolada.

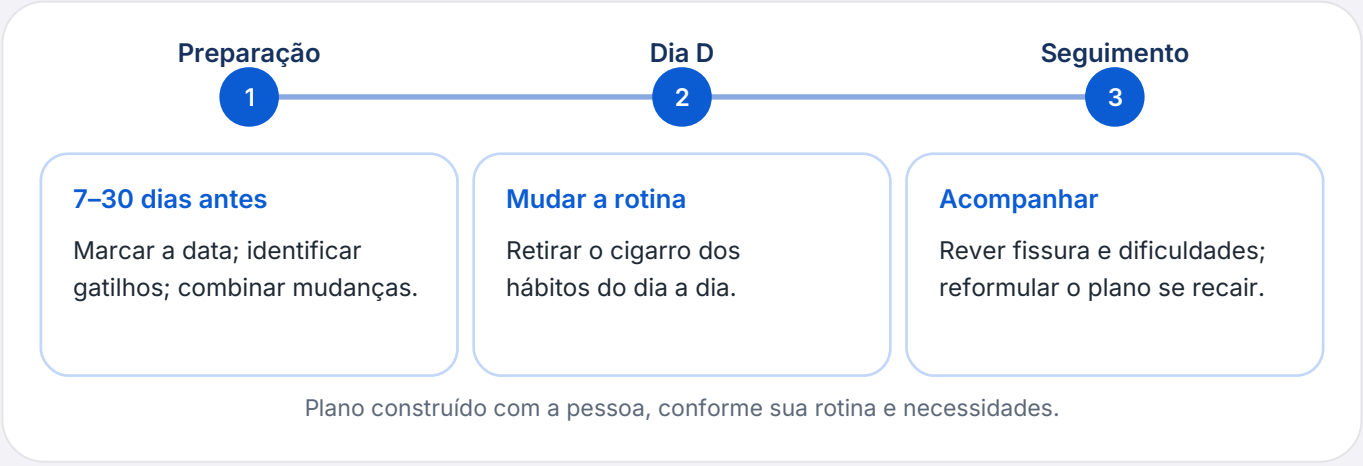
> “Tirei na nossa prova o “cognitivo” porque senão fica um negócio muito psicológico.”
>
> DR. CÁSSIO

Esse apoio inclui aconselhamento estruturado, identificação de gatilhos, estratégias para lidar com eles, plano de cessação e prevenção de recaídas. Há quem pare sozinho ou com apenas uma das abordagens; a escolha precisa considerar a pessoa, sem perder de vista o benefício da combinação.

O plano começa na primeira conversa

A anamnese explora onde e quando a pessoa fuma, há quanto tempo, se outras pessoas em casa fumam, o que já tentou e como foram as experiências anteriores. A preparação se organiza em quatro medidas:

1. **Marcar o Dia D.** Combinar uma data para parar, entre 7 e 30 dias. Um intervalo de cerca de 15 dias permite preparar a mudança.
2. **Iniciar atividade física.** Incluí-la na preparação e na mudança de rotina.
3. **Reconhecer os gatilhos.** Observar os momentos ligados ao cigarro: café, sacada, pós-almoço e saída para o trabalho.
4. **Preparar a redução do uso.** Perceber quais cigarros podem ser evitados e reduzir o consumo até a data combinada.



Plano construído com a pessoa, conforme sua rotina e necessidades.

Entre os exemplos de preparação estão diminuir de 20 para 19, 18 e 17 cigarros, adiar um cigarro que não parece necessário ou não fumá-lo inteiro. Para o pod, a contagem é menos simples; uma possibilidade é reduzir de duas tragadas para uma. Essas estratégias preparam a cessação e precisam ser adaptadas a cada pessoa.

Três dicas que o professor repete

1. **Querer parar.** A vontade e o momento de vida entram na conversa.
2. **Marcar a data.** O Dia D transforma a intenção em um compromisso concreto.
3. **Fazer diferente nesse dia.** Mudar a rotina que ligava o cigarro ao café, ao almoço e aos outros hábitos.

PEGADINHA DO PROFESSOR

Esperar que apenas a medicação faça a pessoa parar de fumar. Ela ajuda com a abstinência e a fissura; a mudança de rotina e o acompanhamento continuam necessários.

Uma linguagem que acolhe

Evite a palavra “vício”, por seu peso moral, e converse sobre hábito e dependência. Uma linguagem respeitosa não retira o caráter de doença nem a necessidade de cuidado.

> “A gente não usa mais a palavra vício, a gente usa o hábito.”
>
> DR. CÁSSIO

SEÇÃO 04

Medicamentos: indicação e diferenças

EM PALAVRAS SIMPLES

A medicação pode aliviar o desconforto de ficar sem nicotina e a vontade de fumar. A escolha depende da história, dos riscos e das necessidades de cada pessoa.

Quando considerar farmacoterapia

Os critérios práticos enfatizados pelo Dr. Cássio são sintomas relevantes de abstinência, consumo maior que 5 cigarros por dia, primeiro cigarro em menos de 1 hora após acordar e Fagerström maior que 4. A decisão é **individualizada**, considerando preferências, contraindicações, comorbidades e tentativas anteriores.

Complemento: fora da aula. A linha de cuidado do Ministério da Saúde inclui os valores de fronteira: 5 ou mais cigarros/dia, primeiro cigarro em até 1 hora e Fagerström igual ou maior que 4. [1]

O Dr. Cássio adota a prescrição para adultos e não utiliza medicação em menores de 18 anos, embora reconheça situações de exceção. Mesmo quem reduziu para 2 ou 3 cigarros por dia e não consegue cessar pode precisar de ajuda, como a goma em situações selecionadas. O número de cigarros não encerra a avaliação.

Reposição de nicotina: lenta e pontual

COMPARAÇÃO	Adesivo	Goma
PERFIL	Liberação lenta ao longo do dia.	Uso pontual para a fissura, com ação mais rápida que o adesivo.
APRESENTAÇÕES	7 mg, 14 mg e 21 mg.	2 mg por unidade.
CUIDADO	Troca diária, alternando os locais; observar reação na pele.	Mastigar de forma intermitente e manter no canto da boca.

Adesivo e goma são as formas de reposição usadas como referência neste material. Pastilhas e spray nasal são outras apresentações mencionadas na prática do tratamento; a disponibilidade precisa ser confirmada para cada produto e local.

Adesivo: o exemplo de quem fuma um maço por dia

Para alguém que fuma 20 cigarros por dia, um exemplo de esquema é começar com 21 mg e reduzir a dose mês a mês, durante três meses. A lógica é repor nicotina enquanto a pessoa deixa de fumar e trabalha os componentes psicológicos e comportamentais.

A orientação do Dr. Cássio é aplicar o adesivo da cintura para cima, com troca diária e rodízio entre locais, considerando a absorção. Se aparecer vermelhidão, é preciso mudar de local; em caso de reação intensa ou persistente, a goma pode ser considerada como alternativa.

1º mês	2º mês	3º mês
21 mg	14 mg	7 mg
um mês nesta etapa	um mês nesta etapa	um mês nesta etapa

EXEMPLO · 20 cigarros/dia
Troca diária e alternância do local de aplicação.

Exemplo para quem fuma 20 cigarros/dia; a escolha e os ajustes dependem da avaliação individual.

Comparação usada no exemplo. O Dr. Cássio utiliza 0,8–1 mg de nicotina por cigarro para explicar a reposição.

Complemento: fora da aula. A quantidade total de nicotina de um produto e a quantidade absorvida não são intercambiáveis; comparações entre cigarro, goma, adesivo e líquido exigem considerar a via e o padrão de uso. [2]

Goma: alívio da fissura

A goma de 2 mg permite uso pontual para a fissura. Entre os exemplos clínicos estão quem ainda fuma 1 ou 2 cigarros por dia e quem está há 5–7 dias sem fumar, mas apresenta vontade intensa. Nessa segunda situação, o Dr. Cássio prefere avaliar a goma antes de iniciar um adesivo, atento ao risco de náusea, tontura e mal-estar.

1. **Mastigar de forma intermitente.** A explicação alterna a mastigação com pausas.
2. **Manter junto à bochecha.** A goma fica no canto da boca entre os períodos de mastigação.
3. **Reavaliar a necessidade.** O uso deve fazer sentido diante da fissura, sem se tornar um gesto automático depois que ela passou.

Na experiência clínica do Dr. Cássio, o alívio da fissura pode ocorrer em cerca de 5 minutos, e alguns pacientes utilizam 3–5 gomas por dia. A comparação informal de uma goma de 2 mg com dois cigarros ajuda a explicar o uso, mas não estabelece uma equivalência exata de absorção.

Complemento: fora da aula. A técnica de mastigar e manter junto à bochecha dura cerca de 30 minutos. O tempo até aliviar a fissura é diferente da duração do uso; 3–5 unidades/dia não definem uma dose máxima universal. [5]

Um caso ilustra a revisão do tratamento: um médico continuava usando goma seis meses depois de parar, sem sentir vontade de fumar. Ao conversar sobre a necessidade real, percebeu que podia interromper esse uso. O ponto didático é reavaliar, não presumir a necessidade indefinida de reposição.

Bupropiona: perfil clínico e risco de convulsão

A bupropiona é um antidepressivo atípico com eficácia para cessação independente do efeito antidepressivo. Atua em vias dopaminérgicas e noradrenérgicas relacionadas à dependência e integra as opções de primeira linha indicadas pela Organização Mundial da Saúde.

História de crise convulsiva e traumatismo cranioencefálico são contraindicações destacadas pelo Dr. Cássio. Antes de prescrever, revise também interações que aumentem o risco de convulsão, o perfil clínico e as medicações em uso.

APRESENTAÇÃO DE LIBERAÇÃO LENTA

Liberação ao longo do dia. A escolha da formulação depende do esquema de tratamento prescrito.

300 mg
BUPROPIONA

Complemento: fora da aula. A apresentação de 300 mg não define a dose inicial. Formulação, titulação e intervalos precisam seguir a bula e o protocolo da apresentação prescrita. [6]

Entre os nomes comerciais estão Zyban, Zetron, Wellbutrin e Bup. Ao selecionar o paciente, pergunte como ele ficou nas tentativas anteriores: irritabilidade e agitação merecem atenção, enquanto o relato de humor rebaixado leva a outra avaliação.

APRENDIZADO DA PRÁTICA · OBSERVAR A TOLERÂNCIA

O Dr. Cássio teve uma experiência pessoal de agitação com a bupropiona. Seu aprendizado é considerar o perfil do paciente e observar a resposta, sem presumir que todos terão a mesma reação: a maioria de seus pacientes tolera bem o medicamento.

Ansiedade: tratar a pessoa, não só o cigarro

A sertralina não é um medicamento específico para cessação. Diante de ansiedade, depressão ou transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, avalie a condição associada e considere o contato com o profissional que já acompanha a pessoa. Um clínico com competência para esse manejo pode avaliar e tratar a comorbidade; reconhecer quando buscar apoio especializado faz parte do cuidado.

> "Eu é que não passo porque não é mais da minha área."
> DR. CÁSSIO

PEGADINHA DO PROFESSOR

Usar bupropiona automaticamente em qualquer pessoa ansiosa. Ela pode causar agitação; a escolha depende do perfil clínico e da revisão de riscos.

Vareniclina: agonismo parcial

A vareniclina, lembrada pelo nome Champix, foi desenvolvida especificamente para a cessação. Liga-se ao receptor nicotínico alfa-4 beta-2 como **agonista parcial**: produz ativação parcial e reduz a ação reforçadora da nicotina quando a pessoa fuma.

A ideia é oferecer parte do estímulo e, ao mesmo tempo, reduzir a recompensa obtida ao fumar. A expressão "30%–40% do prazer", usada pelo Dr. Cássio, é uma analogia para o agonismo parcial; não representa eficácia clínica ou ocupação dos receptores.

Disponibilidade. Antes de considerar a prescrição, confirme a situação comercial da apresentação. A experiência do Dr. Cássio inclui um período de indisponibilidade da vareniclina no mercado brasileiro.

Como comparação ilustrativa, o Dr. Cássio apresenta valores aproximados de cessação de 17% com placebo, 30% com bupropiona e 47% com vareniclina. Em seu grupo, relata 90% de sucesso associando vareniclina e apoio comportamental.

Como interpretar os resultados. Os 90% representam a experiência de um grupo conduzido pelo Dr. Cássio. Não constituem uma taxa garantida nem devem ser comparados diretamente com percentuais de outros grupos.

> "Eu paro de fumar; o que o remédio vai me ajudar? A não ter as crises de abstinência."
> DR. CÁSSIO

SEÇÃO 05

Cessação, recaída e seguimento

EM PALAVRAS SIMPLES

Parar traz benefícios mesmo depois de muitos anos fumando. Se a pessoa voltar a fumar, é preciso entender o que aconteceu e ajustar o plano para a próxima tentativa.

Recaída é informação para ajustar o plano

Se a pessoa volta a fumar, o primeiro passo é entender o que aconteceu. Pergunte sobre fissura, álcool, estresse, festas e outros acontecimentos. Avalie quantos cigarros fumou e se voltou ao padrão anterior ou a uma quantidade menor.

1. **Reconstruir o contexto.** O que aconteceu antes de voltar a fumar?
2. **Identificar o gatilho.** Qual situação ou dificuldade ficou sem resposta no plano?
3. **Combinar uma nova tentativa.** Ajustar a estratégia e retomar o acompanhamento.

> “Recaída não é o fim do tratamento.”
>
> DR. CÁSSIO

PEGADINHA DO PROFESSOR

Achar que parar apaga toda a perda pulmonar ou que a recaída representa fracasso moral. O benefício está em mudar a trajetória; o acompanhamento deve responder às dificuldades que surgem.

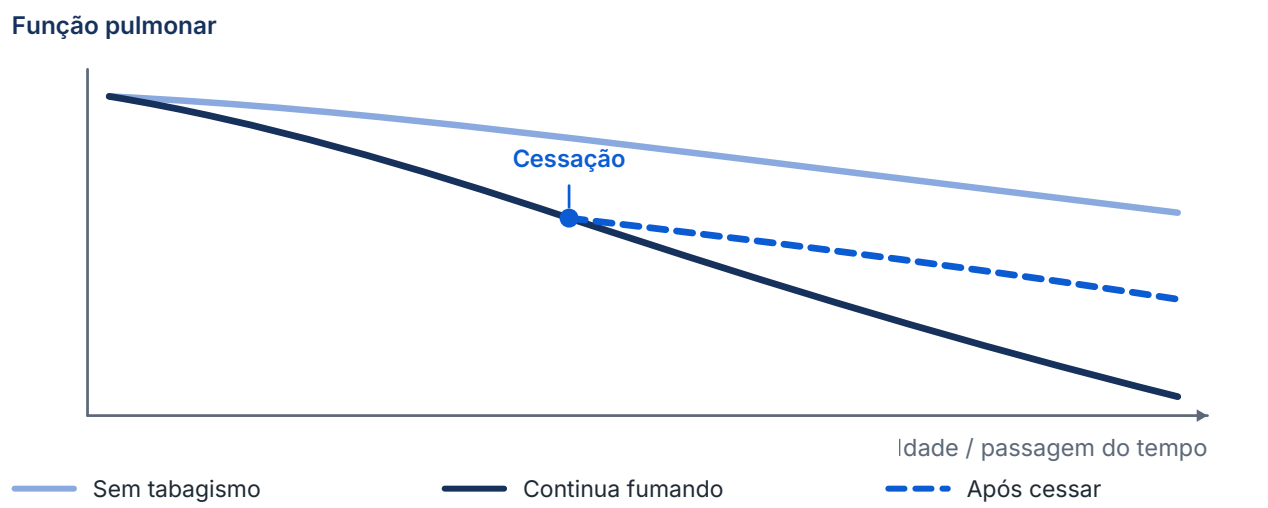
Seguimento individualizado. O período de acompanhamento não significa que o risco de voltar a fumar desapareça depois de um ano. O plano deve acompanhar as necessidades da pessoa.

Parar vale a pena em qualquer idade

A função pulmonar diminui ao longo dos anos, mas o tabagismo acelera a perda. O Dr. Cássio utiliza a ideia de uma perda “três vezes maior” para destacar esse efeito. Ao cessar, a velocidade de perda volta a se aproximar da de quem não fuma; o que já se perdeu não é automaticamente recuperado.

Quanto mais cedo a pessoa para, maior o benefício acumulado. A redução de riscos cardiovasculares, respiratórios e oncológicos é progressiva. Na experiência de consultório do Dr. Cássio, a melhora da aparência pode ser percebida em cerca de 15 dias, embora esse prazo varie entre pessoas.

Em uma pessoa de 85 anos com doença pulmonar obstrutiva crônica, irritação brônquica, secreção e infecções de repetição precisam ser consideradas junto do conforto e dos objetivos de cuidado. A decisão exige ponderação compartilhada; a idade isolada não define quando parar deixa de valer a pena.



Esquema qualitativo, sem escala: cessar reduz a perda futura.

Esquema qualitativo: cessar modifica a trajetória de perda, sem recuperar automaticamente a função anterior.

A família e o tempo de acompanhamento

A cessação beneficia também quem estava exposto à fumaça. Avisar a família ajuda a construir apoio durante a mudança: a irritabilidade não deve virar motivo para estimular o retorno ao cigarro.

Uma estimativa usada pelo Dr. Cássio é de 30% de recaída até nove meses. Sua orientação é acompanhar por **9 meses a 1 ano**, buscando cessação sustentada, com prevenção e manejo de recaídas.

SEÇÃO 06

Cigarros eletrônicos e a conta do rótulo

Dependência | Abordagem | Dia D | Medicamentos | Seguimento | **Dispositivos** | Riscos | Prevenção

EM PALAVRAS SIMPLES

O pod produz um aerossol e pode concentrar muita nicotina. Para entender o consumo, peça a embalagem e verifique a concentração, o volume do refil e quanto tempo ele dura.

O produto mudou; a dependência continua

Vape, pod e cigarro eletrônico são formatos de dispositivos eletrônicos para fumar. Entre seus componentes estão bateria, sensor, reservatório e atomizador. A energia gera um aerossol a partir do produto utilizado; não se trata apenas de vapor de água.

Há apresentações com ou sem nicotina, sais de nicotina, refis aromatizados e produtos de tabaco aquecido. Design discreto, tecnologia, sabores, facilidade de uso, curiosidade e socialização ajudam a explicar o apelo entre jovens.

Por que o sal de nicotina importa?

Ele permite formulações com concentrações elevadas e menor aspereza na boca e na garganta. Isso pode facilitar tragadas repetidas e mais profundas em alguns dispositivos. A sensação de menor irritação não significa menor risco.

A quantidade de nicotina e o padrão de exposição variam entre marcas, dispositivos e formas de uso. Na consulta, peça a caixa do produto, confira a concentração e o volume e pergunte quanto tempo o refil dura.

Como calcular o conteúdo de nicotina

Na convenção usada no exemplo, multiplica-se a porcentagem por 10 para obter a concentração em mg/mL. Depois, multiplica-se pelo volume e divide-se pelos dias de duração:

[(porcentagem × 10) × volume em mL] ÷ dias

Concentração	Volume do refil	Duração do refil
5% × 10	50 mg/mL × 10 mL	500 mg ÷ 10 dias
50 mg/mL	500 mg no líquido	50 mg/dia no líquido

Conteúdo médio de nicotina no líquido consumido por dia.

A conta não determina quanto foi absorvido pelo organismo.

O exemplo considera um refil de 10 mL a 5% que dura 10 dias. São 50 mg/mL, 500 mg no refil inteiro e 50 mg por dia no líquido consumido. O Dr. Cássio utiliza uma comparação aproximada com 2,5 maços por dia para tornar o consumo perceptível ao paciente.

Complemento: fora da aula. A conversão assume porcentagem massa/volume: confira a convenção do rótulo. A conta estima nicotina no líquido consumido, não a dose absorvida. A passagem para o aerossol e a absorção variam; a comparação com 2,5 maços é uma analogia, não uma equivalência clínica validada. [2]

APRENDIZADO DA PRÁTICA · TORNAR O CONSUMO VISÍVEL

Em consultas, o Dr. Cássio chegou a comparações com 3,5 e 7 maços ao discutir o consumo de pacientes. Entender a dimensão do uso ajudou algumas pessoas a decidir parar. A utilidade da conta é abrir essa conversa, sem reduzir todos os dispositivos à mesma equivalência.

PEGADINHA DO PROFESSOR

Usar uma equivalência fixa sem conhecer concentração, volume e duração. Marcas, dispositivos e padrões de uso variam.

Aerossol e regras no Brasil

O aerossol pode conter partículas irritantes, aromatizantes e metais, com efeitos respiratórios e cardiovasculares. Os efeitos de longo prazo continuam sendo estudados.

No Brasil, são proibidas fabricação, importação, comercialização, distribuição, armazenamento, transporte e propaganda desses dispositivos. O uso em ambientes coletivos fechados, incluindo avião e ônibus, também é proibido.

Complemento: fora da aula. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária mantém as proibições na resolução de 2024. A norma não proíbe, por si só, o uso individual, mas proíbe o uso em recinto coletivo fechado. [3]

SEÇÃO 07

Lesão pulmonar e redução de danos

EM PALAVRAS SIMPLES

Produtos inalados podem causar lesão pulmonar aguda grave. Uma estratégia de redução de danos usada em outro país não transforma qualquer vape em um medicamento aprovado.

Lesão pulmonar associada ao uso de cigarro eletrônico

Produtos inalados podem causar **dano pulmonar agudo grave**. Casos de jovens com opacidades intersticiais e alveolares extensas ilustram a importância de investigar a exposição a cigarros eletrônicos.

O dano pode envolver a membrana alvéolo-capilar. A lesão pulmonar associada ao uso desses produtos demonstra o risco agudo, mas não resume todos os efeitos possíveis dos dispositivos.

Complemento: fora da aula. "Pulmão em pipoca" é o nome popular da bronquiolite obliterante; não é sinônimo da lesão pulmonar associada ao uso de cigarro eletrônico. [4]

O argumento de que "na Inglaterra é liberado"

Em uma consulta, um paciente do Dr. Cássio usou a experiência inglesa como argumento de segurança. O aprendizado é distinguir regulamentação, redução de danos e ausência de risco: são questões diferentes.

DISTINÇÃO	Redução de danos	Uso genérico de pod
CONTEXTO	Pessoa que ainda mantém cigarros convencionais após tentativas de redução.	Uso que não corresponde àquele plano específico de redução.
ESTRATÉGIA	Concentração e horários definidos para uma situação delimitada.	Produtos e padrões de consumo variáveis entre usuários e dispositivos.
CONCLUSÃO	Uma estratégia precisa ser entendida no contexto em que foi estudada.	Não permite concluir que qualquer vape seja seguro ou um medicamento aprovado.

PEGADINHA DO PROFESSOR

Concluir que a liberação em outro país prova que não faz mal. Priorize tratamentos com eficácia e segurança estabelecidas; nenhum cigarro eletrônico é aprovado no Brasil para tratar tabagismo.

Complemento: fora da aula. A ausência de aprovação de cigarros eletrônicos para tratamento do tabagismo no Brasil é confirmada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária. [4]

SEÇÃO 08

Prevenção e cuidado compartilhado

EM PALAVRAS SIMPLES

Cuidar do tabagismo também é evitar que outras pessoas comecem e proteger quem convive com a fumaça. Escutar, combinar mudanças e acompanhar faz parte do tratamento.

Estratégias antigas em novos produtos

A publicidade antiga do cigarro e o apelo atual dos dispositivos compartilham elementos: glamour, status, socialização, design, tecnologia, sabores e baixa percepção de risco. O produto fica discreto e atraente, enquanto a dependência continua no centro do problema.

Três frentes de controle

1. **Prevenir o início.** Proteger crianças e adolescentes da iniciação ao tabagismo.
2. **Proteger da exposição passiva.** Reduzir a exposição de familiares e de outras pessoas à fumaça.
3. **Oferecer cuidado.** Apoiar quem deseja parar, inclusive com grupos e acompanhamento.

Para destacar o valor da ajuda, o Dr. Cássio utiliza uma comparação de 85% de pessoas que desejavam parar, 3% que conseguiam sozinhas e 60% com apoio. Esses percentuais ilustram seu argumento sobre a importância do cuidado; não representam uma promessa individual de resultado.

A decisão precisa fazer sentido para a pessoa

Na medicina centrada na pessoa, a mudança de hábito será feita por quem vive aquela rotina. O plano precisa de concordância, escuta e participação.

ABORDAR	Todo usuário merece uma conversa, mesmo sem estar pronto para parar hoje. A oferta de ajuda mantém aberta a possibilidade de mudança.
ESCUTAR	O cuidado envolve compreender o que a pessoa sente, como vive e o que a faz fumar. Sem tempo e paciência para escutar, parte do problema fica sem resposta.
COMBINAR	Apoio comportamental e farmacoterapia, quando indicada, entram em um plano compartilhado. O profissional ajuda a construir a mudança, em vez de apenas impor uma lista de ordens.

> “É mudança de hábito de vida, e quem vai fazer é a pessoa, não é você; então ela precisa estar de acordo com aquilo que vai fazer.”
>
> DR. CÁSSIO

SEÇÃO 09

Página de véspera

Revise na ordem da trilha: entender a dependência, planejar a cessação e acompanhar o cuidado. O selo PROVA destaca a orientação do professor.

Dependência. Física, psicológica e comportamental. A nicotina é central, mas a rotina também precisa mudar.

Avaliação. Perguntar, aconselhar, avaliar, ajudar e acompanhar. Faixas iniciais de Fagerström: 0–2 muito baixa; 3–4 baixa; 5 média. Sempre junto da história clínica.

Apoio comportamental PROVA **.** Expressão orientada pelo Dr. Cássio para a prova. Combinar Dia D entre 7 e 30 dias; reconhecer gatilhos, preparar a mudança e reorganizar a rotina.

Farmacoterapia. Abstinência relevante; >5 cigarros/dia; primeiro cigarro <1 hora; Fagerström >4. Individualizar. Na prática do Dr. Cássio, medicação apenas para adultos.

Reposição de nicotina. Exemplo: adesivo 21 mg, 14 mg e 7 mg, um mês em cada etapa, troca diária. Goma citada: 2 mg para situações de fissura. Não equivaler diretamente produtos.

Outros medicamentos. Bupropiona: história de convulsão e traumatismo craniano são contraindicações; revisar interações e agitação. A apresentação de 300 mg não define o início. Vareniclina: agonista parcial alfa-4 beta-2.

Seguimento. Recaída pede identificação de gatilhos e novo plano. Acompanhamento descrito: 9 meses a 1 ano. Parar reduz a velocidade de perda pulmonar; não apaga a perda anterior.

Conta do pod. 5% = 50 mg/mL; refil de 10 mL = 500 mg; duração de 10 dias = 50 mg/dia no líquido. A conta não determina dose absorvida nem equivalência exata com maços.

Riscos e prevenção. Aerossol não é vapor de água. Pode haver lesão pulmonar aguda grave. O dispositivo não é tratamento aprovado no Brasil. Prevenir o início, proteger da exposição passiva e apoiar a cessação.

Doses e critérios precisam ser interpretados junto da avaliação individual. Consulte os capítulos para as diferenças entre apresentações e as referências complementares.

SEÇÃO 10

Palavras da aula em linguagem simples

Abstinência	Sintomas que aparecem após interromper ou reduzir o uso de uma substância à qual havia dependência.
Agonista parcial	Substância que ativa um receptor, mas produz resposta menor que a de um agonista pleno.
Alfa-4 beta-2	Tipo de receptor nicotínico envolvido na dependência e na ação da vareniclina.
Ambivalência	Ter, ao mesmo tempo, razões para mudar e razões para manter o comportamento.
Atomizador	Parte do dispositivo que participa da formação do aerossol a partir do produto utilizado.
Fissura	Vontade intensa de usar a substância, como a vontade intensa de fumar.
Gatilho	Situação, emoção ou hábito que desperta a vontade de fumar.
Membrana alvéolo-capilar	Barreira fina entre o ar dos alvéolos e o sangue dos capilares, onde ocorrem as trocas gasosas.
Noradrenérgico	Relacionado à noradrenalina, uma substância que participa da comunicação entre células do sistema nervoso.

Referências complementares

Leituras de apoio aos esclarecimentos clínicos destacados em roxo.

1. Ministério da Saúde. Linha de cuidado do tabagismo — planejamento terapêutico.
2. Blank e colaboradores, 2020. Estudo de entrega de nicotina: concentração, duração da tragada e exposição. Repositório dos Centros de Controle e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos.
3. Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Cigarro eletrônico — regulamentação e informações oficiais.
4. Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Perguntas frequentes — tratamento e riscos, itens 2 e 4.
5. Centros de Controle e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos. Orientações para uso da goma de nicotina.
6. DailyMed, Biblioteca Nacional de Medicina dos Estados Unidos. Bula de bupropiona de liberação sustentada para cessação.

ANOTAÇÕES